

Greffe de muqueuse buccale (joue)

Information pour le patient · La greffe de joue utilisée pour reconstruire votre urètre ou urètre

WARWIKI

Dans le cadre de votre chirurgie reconstructive, votre chirurgien prélève un petit fragment de la muqueuse humide de l'intérieur de votre joue — une greffe de muqueuse buccale — pour reconstruire votre urètre (ou, plus rarement, votre urètre, le tube reliant un rein à la vessie). Cette fiche explique pourquoi la joue est utilisée, ce qui se passe et comment votre bouche va cicatriser.

À propos de cette greffe

L'intérieur de votre joue est tapissé d'un tissu résistant et humide qui convient parfaitement aux voies urinaires. Un fin fragment ovale est prélevé sur une joue (parfois les deux, pour une réparation plus longue) et utilisé pour élargir ou reconstruire la zone rétrécie. Le prélèvement se fait **pendant que vous dormez, au cours de la même opération** que votre réparation.

Pourquoi l'intérieur de la joue ?

- Ce tissu est glabre et habitué à un milieu humide, comme les voies urinaires
- Il est résistant, cicatrise vite avec peu de tissu cicatriciel et résiste à l'infection
- Il est prélevé lors de la même intervention — aucune incision supplémentaire sur le corps, aucune cicatrice visible

Est-ce sans danger ?

Oui. Le prélèvement d'une greffe de joue est une étape bien établie et bien tolérée de la chirurgie urétrale, avec un taux de satisfaction très élevé. Votre chirurgien évite le canal salivaire et le coin de la bouche. La plupart des effets concernent la bouche — sensibilité, tension ou engourdissement — et s'atténuent dans les deux premières semaines. Un prélèvement sur les deux joues est plus douloureux ; il n'est utilisé que si la réparation l'exige.

COMPRENDRE LES TERMES

Muqueuse buccale

La muqueuse humide qui tapisse l'intérieur de la joue.

Greffe

Fragment de votre propre tissu transplanté pour réparer une autre zone.

Urètre

Le canal qui conduit l'urine hors du corps.

Urétroplastie

Chirurgie de réparation de l'urètre ; la greffe buccale en fait partie.

Site de prélèvement

L'endroit où la greffe est prélevée — ici, l'intérieur de la joue.

Anesthésie générale

Médicament qui vous endort et supprime la douleur pendant l'opération.

Canal salivaire (parotidien)

Petit orifice dans la joue qui draine la salive ; votre chirurgien l'évite.

Trismus

Raideur ou difficulté temporaire à ouvrir grand la bouche ; s'améliore avec des étirements doux.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La greffe est prélevée pendant que vous dormez sous anesthésie générale : vous ne sentez rien pendant l'opération. Ensuite, la joue est douloureuse — comme une morsure ou un aphte — et peut sembler tendue ou engourdie. La douleur s'améliore en 1–2 semaines. La plupart des patients boivent dès le lendemain et remangent normalement en une semaine.

Comment vous préparer (avant la chirurgie)

- La greffe est prélevée lors de votre chirurgie reconstructive, **sous anesthésie générale** — suivez toutes les instructions habituelles (jeûne et médicaments à suspendre).
- **Prenez soin de votre bouche** au préalable — brossez-vous les dents et rincez soigneusement ; votre équipe peut vous demander un détartrage dentaire.
- **Ne fumez pas, ne vapotez pas et n'utilisez pas de tabac** — cela ralentit la cicatrisation buccale et la prise de greffe. Arrêter avant l'opération est très bénéfique.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Avez subi une chirurgie de la bouche, de la joue ou de la mâchoire, ou une radiothérapie de la tête ou du cou
- Avez une affection buccale ou des difficultés à ouvrir grand la bouche
- Mâchez du tabac ou de la noix de bétel, ou avez des problèmes dentaires persistants

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous dormez sous anesthésie générale pendant toute l'intervention, et votre bouche est maintenue ouverte délicatement.
- 2 Votre chirurgien prélève un fin fragment ovale de muqueuse sur une joue (les deux pour une réparation plus longue), en évitant le canal salivaire et le coin de la bouche.
- 3 La greffe est façonnée et utilisée pour élargir ou reconstruire la zone rétrécie des voies urinaires.
- 4 La joue est généralement laissée à cicatriser seule ou refermée avec des points résorbables.

Après la chirurgie (votre bouche)

- La douleur et la tension **s'améliorent en 1–2 semaines** ; la joue cicatrise sur environ un mois et **l'engourdissement peut durer un mois ou plus**.
- Mangez des **aliments mous et neutres** au début ; évitez les aliments épicés, acides, très chauds ou croquants ainsi que l'alcool. Rincez doucement après les repas.
- Effectuez chaque jour des **étirements doux de la bouche** pour réduire la tension. Il n'y a **aucune cicatrice visible** — la greffe est à l'intérieur de la bouche.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Un saignement abondant ou persistant de la bouche
- Une douleur buccale qui s'aggrave, un gonflement ou du pus (infection)
- Une impossibilité de boire ou d'ouvrir la bouche

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Un petit fragment de muqueuse humide de la joue sert à reconstruire votre urètre — il est glabre, cicatrise bien et ne laisse aucune cicatrice visible.
2. Il est prélevé pendant que vous dormez, lors de votre réparation urétrale. Pour vous préparer, suivez les consignes de jeûne et de médicaments, soignez votre bouche et ne fumez pas.
3. Votre joue sera douloureuse, tendue ou engourdie — cela **s'améliore en 1–2 semaines**, mais peut mettre un mois ou plus. Mangez mou, rincez doucement et faites des étirements quotidiens.